

Назва міністерства, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я Міністерство охорони здоров'я України Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма КНП ЛОР "ЛОКЛДКЦ" Львів м., Кульпарківська, 35	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма первинної облікової документації № 027/о ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 14.02.2012 року № 110
Код за ЄДРПОУ 2 0 7 6 1 1 1 2	

ВИПИСКА
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

У _____ за місцем вимоги
(найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого: **Ільницький Юрій Іванович**
2. Дата народження: **15.04.1994**
3. Місце проживання/хворого: **Золочів м., вул.Польна 28 кв.39**

4. Місце роботи (посада): **ЕПАМ Діджитал, старший інженер розробник**

5. Дати а) в амбулаторно-поліклінічному закладі: _____ захворювання
_____ направлення в стаціонар
б) у стаціонарі: _____ надходження
_____ виписки або смерті (підкреслити)

20.03.2024

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення)
Хронічна ревматична хвороба серця, в'ялопротікаючий ревмокардит. Мітральна вада серця: недостатність мітрального клапана 2+. Ущільнення стулок аортального клапана. Постміокардитичний кардіосклероз. Порушення ритму і провідності серця у вигляді частоті надшлуночкової і шлуночкової екстрасистолії, пароксизмів надшлуночкової тахікардії (транзиторний синдром преекзитації (CLC)). Блокада задньої гілки лівої ніжки п. Гісса. Артеріальна гіпертензія II, кризовий перебіг, ст. 3, ризик високий 3. СН II фк із помірно зниженою систолічною функцією лівого шлуночка. Виражена екстравазальна компресія правої ХА.

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці
Скарги на задишку при помірних фіз. навантаженнях, часті артралгії, субфебрилітет, болі в ділянці серця, втому, часті підйоми АТ до 180/110 мм рт ст на фоні прийому комбінованої антигіпертензивної терапії, болі голови, головокружіння, запаморочення, часто епізоди прискореного серцебиття на фоні незначних фіз на емоційних навантажень. В анамнезі з дитинства ревматизм. Постійно лікується амбулаторно, в 2018р консультований в кардіоцентрі, отримує біцилінотерапію. АГ близько 5 р (кризовий перебіг на фоні прийому еналозид, бісопролол). Восени 2022р д-но гострий міокардит після перенесеного ГРВІ, ковід-19. Поступове погіршення стану останній місяць, у зв'язку з чим лікувався стаціонарно в терапевтичному відділенні ЦРЛЗ 27.02. по 04.03.24р (витяг додається)
Об-но: ЧСС- 110 уд/хв. АТ- 170/100 мм рт ст (на фоні прийому комбінованої антигіпертензивної терапії). Серцеві тони аритмічні, ослаблені, акцент II тону над аортою, систолічний шум над верхівкою. Над легеньми везикулярне дихання, в н/в ослаблене. Пастозність стоп.
ЕКГ, ЕХОКГ, УЗД ГДА, щ.з, нирок, наднирників, судин нирок - додається.

8. Лікувальні і трудові рекомендації
Продовжувати лікування під "Д" наглядом с/лікаря. Холтер ЕКГ. Санація хрон. вогнищ інфекції. Обмеження фізичних навантажень. До лікування додати кораксан 5 мг*/2р/д, верошпірон 25 мг/д.

21.03.24

